

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	剖腹生產之準備與護理 Preparation and Care of Cesarean Section				
編號	A31000-Q05-W-C06	制定者	R9 洪映廷	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.9 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作剖腹生產之準備與護理技術。

二、範圍

護理部婦產科、產房。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.給予完整的手術前衛教，減少病人及家屬的擔心、害怕。
- 2.提供合宜的護理措施，減少術後併發症的發生。
- 3.減輕疼痛，增進舒適。
- 4.預防感染，促進傷口癒合。
- 5.促進親子依附關係早期建立。

（二）用物準備：

1.皮膚準備的用物：

安全剃刀 1 把、清潔手套 1 副、看護墊一片及衛生紙數張。

2.灌腸用物：

清潔手套 1 副、衛生紙數張、Jelly 一包、灌腸套 1 個。

3.手術衣 1 件。

4.靜脈注射用物及溶液依醫囑。

5.存留導尿包 1 包及用物。

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/9

(三) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1.核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2.辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋剖腹生產之準備與護理之過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3.洗手及準備用物。	
手術前一天的護理與準備	
1.給予心理支持	
(1)由醫師向待產婦及家屬解釋手術名稱、部位、麻醉方式及可能的併發症。	
(2)鼓勵待產婦表達其害怕及擔心，適時給予澄清。	
(3)執行任何護理活動前，均需給予詳細的解釋。	
2.生理評估	
(1)瞭解待產婦過去的產科及內科病史。	
(2)血液檢查：包括血球計數、生化。	* 血液檢查： A. BT、HIV、HCV、PT、PTT 則視需要進行。 B. 若病歷上沒有 ABO、RH type 等檢驗資料則需進行檢驗。
(3)尿液檢查。	
(4)心電圖。	
3.護理措施	
(1)術前衛教	
A. 手術前的禁食：衛教手術前晚午夜後開始禁食、禁水，禁食時間達 6~8 小時。	
B. 說明手術前灌腸、皮膚準備、手術前給藥、靜脈點滴注射(20#Catheter)、存留導尿管、早期活動的必要性以及母乳哺餵的優點、親子同室及產後肌膚接觸之介紹。	
C. 預防手術後併發症的衛教：深呼吸、咳嗽、翻身及腿部運動。	
(2)填寫手術及麻醉同意書。	待產婦對手術有一完整的瞭解後協助

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/9

步驟	說明
	醫師及孕婦填寫手術同意書，會診麻醉科門診填寫麻醉同意書；確認手術及麻醉同意書是否簽署完整。
(3)無壓力試驗 30 分鐘。	
(4)皮膚準備	
A. 核對醫囑，洗手後準備用物至待產婦單位。	
B. 核對待產婦，並向待產婦解釋皮膚準備及灌腸的目的。	二種辨識方法。
C. 圍圍簾及調整室內光線。	
D. 適當露出皮膚準備之範圍。	
E. 剃蘚的範圍應該由劍突處（乳線以下）開始往下一直到大腿上段 1/3 處。	
F. 繃緊皮膚，剃刀與皮膚約成 30 度角，順著毛髮生長方向剃。	
G. 以紗布沾溫水，將皮膚擦拭乾淨。	
H. 整理待產婦單位及用物。	
I. 回到護理站清理用物並洗手。	
J. 記錄。	
(5)促進休息和睡眠	
A. 鼓勵說出內心的焦慮不安。	
B. 清潔全身，促進肌肉鬆弛。	
C. 必要時，依醫囑於睡前給予鎮靜劑以促進安眠。	
手術當天的準備與護理	
1.洗手後準備用物至待產婦單位。	
2.核對待產婦，並測量生命徵象及胎心率。	
3.待產婦更換手術衣、去除指甲油、唇膏、腮紅、移除身上裝飾物，包括戒指、手環、耳環、別針等、移除非固定假牙、隱形眼鏡。	只單著手術衣及穿免洗內褲。
4.戴上手圈，正確固定好。	
5.設置靜脈輸注溶液。	
6.確認待產婦禁食時間足夠。	
7.灌腸。	
8.放置存留導尿管。	等開刀房通知。
9.整理待產婦單位及用物。	

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/9

步驟	說明
10.回到護理站清理用物並洗手。	
11.完成手術前病人辨識單記錄。	
12.檢查病歷資料是否完整。	
13.核對醫囑，並從單位內 ADC 藥車領藥，準備手術中所需用藥。	
14.送待產婦至開刀房。	
剖腹產後立即護理	於 POR 觀察半小時至一小時，而後穩定移至產後病房。
1. 維持合宜的姿勢	
(1)全身麻醉者：採辛氏臥位或平躺頭側一邊，直到完全清醒為止。	
(2)腰椎麻醉者：至少平躺 6~8 小時，勿將頭抬高。	
(3)硬膜外麻醉者：無限制。	
2. 預防出血	
(1)密切監測生命徵象依醫囑。	
(2)觀察惡露量、性質、顏色，必要時更換產墊。	
(3)經常檢視腹部傷口敷料是否有出血。	
(4)使用束腹帶加壓。	
(5)觀察每小時尿量應大於 30 c.c.，共監測 6 次。	
(6)依醫囑給予子宮收縮劑。	
3. 促進良好氣體交換	
(1)每 2 小時行深呼吸及咳嗽一次，每次約 5-10 分鐘，至少持續 48 小時。	
(2)腰椎麻醉後 6~8 小時或全身麻醉清醒後，每 15 分鐘時施行一次腿部運動；每 2 小時翻身一次，持續 24 小時，或至產婦能下床活動為止。	
剖腹產後持續的產後期護理	於產後病房執行。
1.促進血循，預防血栓性靜脈炎	
(1)每 2 小時翻身一次，行膝、踝關節彎屈及伸展等運動。	
(2)手術當天或手術後第一天，採漸進式下床。	
2.供給足夠營養促進體液電解質平衡	
(1)手術後最初 24 小時內必須正確紀錄輸出、入量，並提供靜脈輸液 24~48 小時。	

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/9

步驟	說明
(2)若排氣後：先嚐試喝些水→再試流質飲食→軟質飲食→普通飲食。	
(3)產後 24hrs 仍無蠕動，則依醫囑給予藥物使用。	
(4)進食後若有嚴重及持續的嘔吐現象，則依醫囑給予止吐劑。	
3.維持足夠的腎臟功能	
(1)尿管通常需留置 1 天，並執行導尿管護理。	
(2)記錄第一次排尿時間（6hrs 內、量及性狀）。	
4.減輕疼痛增進舒適	
(1)需要時依醫囑立即給予止痛劑。	
(2)鼓勵產婦的重要關係人前來探訪，可分散產婦對疼痛的注意力。	
(3)促進舒適的措施：以枕頭支托身體部位、口腔護理、背部按摩、身體清潔、保持床單平整、給予安靜的環境以協助其休息等。	
(4)鼓勵哺餵母乳，以促進子宮收縮。	
(5)減輕腹脹所造成的不適。	
5.促進傷口癒合預防感染	
(1)密切觀察腹部傷口與周圍皮膚是否有紅腫熱痛等現象。	
(2)保持傷口的清潔乾燥。	
(3)若為不吸收縫線，通常在第 5~8 天由醫師拆線。	
6.促進親子依附關係的建立	
(1)提供嬰兒的資料給母親，如性別、體重、進食情況等。	
(2)與母親討論她對剖腹產的感覺。	
(3)通常產後第 2~3 天，母親可學習如何照顧自己及新生兒。	
7.出院衛教	
(1)教導產婦瞭解腹部傷口感染與產後合併症的徵象。	
(2)產後最初 4~6 星期應避免粗重的工作，且需有充份的休息。	
(3)性生活及家庭計劃之指導。	
(4)約出院 1~2 週內返院進行產後檢查。	

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/9

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲 (2020)．產科護理學（十版）．台北：新文京。
- (二) 李淑杏、陳迺茹、張淑文、王淑芳、黎小娟、周利娜、陳家盈、謝玉惠、金坤明 (2025)．產兒科護理技術（五版）．台北：華杏。
- (三) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、黃樹欽、孫瑞瓊、林淑玲、吳婉如、陳怡靜、徐莞雲、張靖梅、吳寶觀、劉麗君、陳恩惠、蔡旭美、蔡昀芮、傅雅麟、孫惠玲、侯本昕 (2022)．產科護理學（十一版）．台北：新文京。

七、附件

(略)

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.14	2.1	1.病患改病人。 2.用物準備：刪除大棉棒，新增看護墊。 3.刪除以大棉棒沾肥皂水塗抹。	100 年 12 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
101.10.03	2.2	新增：步驟 3.準備用物。	101 年 10 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	3.1	1.步驟及要點說明：文辭修改及新增文字內容。 2.新增參考資料。	103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.2	1.第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 2.更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.3	1. 第三項第(二)目用物準備內容部份刪修。 2. 修正第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。
106.12.27	3.4	更新第六項參考資料。	106 年 12 月 27 日護理長會議通過。
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過； 108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
110.01.19	3.6	修正第三項第三目步驟及要點說明，3.護理措施(2)填寫同意書說明，麻醉同意書填寫地點改為麻醉科門診。	109 年 12 月 14 日護理技術組會議通過；110 年 01 月 13 日護理長會議通過；110 年 01 月 19 日督導會議通過公布。
111.03.08	3.7	1. 修正第三項第三目中手術前一天的護理與準備 3.(2)手術及麻醉同意書之填寫說明並「確認同意書是否簽署完整」。 2. 更新及修正第六項參考資料。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過；111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
112.03.07	3.8	1. 第三項第二目之用物準備修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過；112 年 02 月 08 日護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.19	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.9	1.新增第三項第二目之準備手術用藥。 2.第六項參考資料修訂。	114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 11 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。

主題名稱	剖腹生產之準備與護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註